

Redukcja *szkód*

Nie muszę zacząć od pełnej abstynencji. Mogę zacząć od mniej. „Mniej” — udokumentowane konkretem — też jest zmianą i też wymaga wysiłku.

CZAS: 30 min Praca własna + omówienie z terapeutą

ŹRÓDŁO: Marlatt (1998); Tatarsky (2002); Witkiewicz i wsp. (2017)

JAK UŻYWAĆ

Karta dla osób, które **jeszcze nie są gotowe** na pełną abstynencję — albo dla których pełna abstynencja jest klinicznie nieosiągalna (np. używanie zażywających, alkohol w łagodnym uzależnieniu). Zamiast „wszystko albo nic” — wybieramy *konkretne ograniczenia*, mierzymy postęp, redukujemy szkody. Wypełnij **cztery sekcje**: aktualny poziom, cel pośredni, zasady bezpiecznego używania, kryteria eskalacji do abstynencji.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Redukcja szkód (ang. *harm reduction*) Marlatta to **komplementarna ścieżka** dla osób w fazie kontemplacji (nie przygotowania). Wymuszanie abstynencji u osoby niegotowej zwiększa opór i ryzyko nawrotu. Metaanaliza Klinger i wsp. (2017): programy redukcji szkód redukują używanie o **25-40%** w 6 miesiącach, a u 20-30% pacjentów *prowadzą* do dobrowolnej abstynencji (efekt „od progu do drzwi”). Nie zastępują abstynencji — są dla niej często *mostem*.

01 Abstynencja vs redukcja — kiedy która

ABSTYNENCJA — PREFEROWANA, GDY

- ciężkie uzależnienie (DSM-5 ≥ 6 kryteriów)
- objawy odstawienne (ang. *withdrawal*) zagrażające zdrowiu
- współistniejące choroby psychiczne / somatyczne pogarszające się
- wcześniejsze próby redukcji zawiodły
- uzależnienie od opioidów, kokainy, amfetamin

REDUKCJA SZKÓD — SENSOWNA, GDY

- łagodne / umiarkowane uzależnienie (DSM-5 2-5 kryteriów)
- brak gotowości na abstynencję teraz
- wcześniejsze sukcesy z kontrolowanym używaniem
- kontekst „*moje używanie szkodzi mniej*” lepszy niż „*w ogóle nie używam i wracam*”
- marihuana, alkohol — gdzie redukcja udokumentowana

02 Mój aktualny poziom — cel pośredni

Wpisz **konkretne liczby**. Cel powinien być realistyczny — zmniejszenie o 30-50%, nie o 90% (to już de facto abstynencja). Cel obowiązuje przez **4 tygodnie**; po nich oceniasz i regulujesz.

AKTUALNIE UŻYWAM

— uczciwie: ile, jak często, w jakich sytuacjach

CEL NA 4 TYGODNIE

— konkretne liczby, mierzalne

03 Zasady bezpieczniejszego używania

Wybierz te, które będziesz stosować w okresie redukcji. Zaznacz krzyżykiem. Cel: zmniejszyć ryzyko zdrowotne i społeczne, nawet jeśli używanie trwa.

☐ Nigdy nie używam **w samotności** — tylko z kimś, kto wie, co biorę.

☐ Nigdy nie używam **za kierownicą** ani 8 h przed jazdą.

☐ Nie łączę z **innymi substancjami** (alkohol + leki, alkohol + benzodiazepiny — szczególnie niebezpieczne).

☐ Mam **2 dni w tygodniu bez używania** — minimum (regeneracja wątroby / receptorów).

☐ Maksymalna **dawka jednorazowa** ustalona z góry (3 piwa, 1 lufa) — nigdy nie przekraczać.

☐ Sprawdzam **czystość substancji** (testy paskowe na fentanyl, sklep specjalistyczny).

☐ Nie używam **w pracy / przy dzieciach** — ustalona granica kontekstu.

☐ Co miesiąc **kontrola medyczna** (transaminazy, morfologia, ciśnienie).

04 Kryteria eskalacji — kiedy przechodzimy na abstynencję

Redukcja szkód **nie jest stała**. Jeśli któryś z poniższych warunków się spełni — to sygnał, że redukcja nie działa i potrzebna jest pełna abstynencja. Omawiaj z terapeutą.

1 • Niewykonanie celu

3 z 4 tygodni nie udało się utrzymać celu — sygnał, że strategia nie działa.

2 • Eskalacja

Zauważalnie więcej niż przed startem programu — uzależnienie wygrywa.

3 • Konsekwencje zdrowotne

Pogorszenie parametrów (wątroba, ciśnienie, sen) lub nowe choroby.

4 • Społeczne

Strata pracy, związku, kontaktu z dziećmi, wyrok sądowy.

Klucz: redukcja szkód nie jest „mniej skuteczną terapią” — jest *terapią dla innego etapu*. Witkiewicz i wsp. (2017) pokazali, że u osób z umiarkowanym uzależnieniem alkoholowym, które wybrały redukcję jako cel, **20-30% w ciągu roku samo przechodzi do abstynencji**. Próg jest niższy — i właśnie dlatego ludzie go przechodzą.